

Complicaciones sistémicas, gastrointestinales y neoplásicas del VIH

Fiebre sin foco y síndrome consuntivo · Diarrea, esofagitis y hepatopatía · Citopenias, sarcoma de Kaposi y linfomas

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección VI (Infección por VIH y sus complicaciones)

Glosario de siglas: TARV: terapia antirretroviral · CD4: linfocitos T CD4 · CV: carga viral · CMV: citomegalovirus · MAC: complejo *Mycobacterium avium* · VEB: virus de Epstein-Barr · VHH-8: virus herpes humano 8 · SK: sarcoma de Kaposi · LNH: linfoma no Hodgkin · PJP: neumonía por *Pneumocystis jirovecii* · SIRS: síndrome inflamatorio de reconstitución inmune · EDA: endoscopia digestiva alta · TMP-SMX: trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol) · PTI: púrpura trombocitopénica inmune · PTT: púrpura trombocitopénica trombótica · VHB/VHC: virus hepatitis B / C.

Alcance y fuentes. Documento orientado al residente que recibe a un paciente con VIH en urgencia o sala. Basado en las guías del panel NIH/CDC/IDSA de infecciones oportunistas, guías EACS, recomendaciones OMS y textos de referencia (UpToDate, MKSAP). Los esquemas oncológicos se describen solo para reconocer la entidad y derivar: **la decisión terapéutica es del hematólogo/oncólogo. Verificar la norma vigente del MINSAL y el protocolo institucional antes de aplicar cualquier esquema.**

Índice

1. El principio que ordena el tema: los CD4 y la TARV cambian el diferencial
2. Fiebre sin foco en el paciente con VIH
3. Síndrome consuntivo (*wasting*) y baja de peso
4. Diarrea aguda y crónica
5. Odinofagia y esofagitis
6. Compromiso hepático y de la vía biliar
7. Citopenias
8. Sarcoma de Kaposi
9. Linfomas asociados al VIH
10. Otras neoplasias y el tamizaje que corresponde
11. Compromiso renal, cutáneo y oftalmológico
12. Cuándo el problema es la TARV y no una infección
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema: los CD4 y la TARV cambian el diferencial

Ante cualquier síntoma en una persona con VIH, tres preguntas ordenan el pensamiento **antes** de pedir exámenes:

1. **¿Cuál es el recuento de CD4 actual (o el nadir)?** Define qué oportunistas son posibles. Con CD4 > 500 el diferencial es esencialmente el de la población general.
2. **¿Está en TARV y con carga viral indetectable?** Un paciente con CV suprimida y CD4 recuperados **no** hace oportunistas clásicos; buscar causas no relacionadas al VIH, toxicidad de fármacos o comorbilidad.
3. **¿Inició TARV en las últimas 4-12 semanas?** Abre el diagnóstico de **SIRS**, que puede desenmascarar una infección latente o inflamar una ya tratada.

CD4 (cél/s/μL)	Espectro que se abre
> 500	Igual a la población general; TB y neumonía bacteriana ya aumentadas

CD4 (cél/s/μL)	Espectro que se abre
200-500	TB, neumonía bacteriana, candidiasis oral, SK, linfoma, herpes zóster
50-200	PJP, toxoplasmosis, esofagitis candidiásica, criptococosis, histoplasmosis
< 50	CMV (retinitis, colitis), MAC diseminado, linfoma primario del SNC, LMP

Regla práctica. El recuento de CD4 orienta, pero **una CV detectable con CD4 altos no descarta TB ni neumococo**: esas dos ocurren en cualquier nivel de inmunidad y son las infecciones más frecuentes en personas con VIH en Chile.

2. Fiebre sin foco en el paciente con VIH

2.1 Causas por frecuencia

Grupo	Entidades	Pistas
Micobacterias	TB (pulmonar y extrapulmonar), MAC diseminado (CD4 < 50)	TB: cualquier CD4, sudoración, baja de peso. MAC: fiebre, anemia, FA elevada, hepatoesplenomegalia
Hongos endémicos/opportunistas	Criptococosis, histoplasmosis (importada), <i>Pneumocystis</i>	AgCr sérico, antigenuria de <i>Histoplasma</i> si epidemiología
Virus	CMV, VEB, primoinfección VIH, virus respiratorios	CMV: CD4 < 50, citopenias, elevación de transaminasas
Bacterias	Bacteriemia por neumococo, <i>Salmonella</i> no tifoidea (recurrente = etapa C), infección de catéter	Hemocultivos
Neoplasias	Linfoma (fiebre B), enfermedad de Castleman multicéntrica (VHH-8)	Adenopatías, LDH, esplenomegalia
Fármacos	Cotrimoxazol, abacavir (hipersensibilidad), nevirapina	Temporalidad, eosinofilia, exantema
SIRI	Cualquier oportunista desenmascarado	TARV reciente + caída de CV + alza de CD4

2.2 Estudio inicial razonable

- Hemograma con recuento diferencial, VHS/PCR, perfil hepático (**fosfatasas alcalinas altas orientan a MAC, TB o linfoma**), LDH (alta en PJP, linfoma, histoplasmosis), creatinina.
- CD4 y carga viral actuales** — sin ellos no se puede razonar el caso.
- Dos sets de hemocultivos corrientes + hemocultivos para micobacterias** (frasco específico) si CD4 < 100.
- Radiografía de tórax; TC de tórax/abdomen si persiste sin foco.
- AgCr sérico si CD4 < 100.
- Baciloscopías/Xpert MTB/RIF en expectoración; en Chile la TB es diagnóstico obligado de descartar y de **notificación obligatoria**.
- Fondo de ojo si CD4 < 50 (retinitis por CMV puede ser asintomática).

Callout. En un paciente con VIH avanzado, fiebre y fosfatasas alcalinas desproporcionadamente altas con anemia, pensar en **MAC diseminado, TB o linfoma** antes que en colestasia obstructiva.

3. Síndrome consuntivo (*wasting*) y baja de peso

Definición clásica (etapa C, CDC): pérdida involuntaria > 10 % del peso basal más diarrea crónica (>= 30 días) o debilidad y fiebre crónica, en ausencia de otra causa explicativa.

Enfrentamiento:

- Es un **diagnóstico de exclusión**: primero descartar TB, MAC, linfoma, criptosporidiosis crónica, insuficiencia suprarrenal (CMV, TB) e hipogonadismo.
- Evaluar depresión, consumo de sustancias e inseguridad alimentaria: **con frecuencia la causa es social, no infecciosa**.
- El tratamiento fundamental es **iniciar o corregir la TARV** más soporte nutricional. Los estimulantes del apetito y los anabólicos tienen evidencia limitada y no deben indicarse de rutina.

4. Diarrea aguda y crónica

4.1 Marco general

Preguntas que ordenan: ¿aguda (< 14 días) o crónica (> 30 días)? ¿inflamatoria (fiebre, sangre, pujo) o acuosa? ¿CD4? ¿fármacos nuevos? ¿relaciones sexuales anales receptivas (proctitis de transmisión sexual)?

4.2 Etiologías según patrón y CD4

Patrón	CD4 > 200	CD4 < 100
Aguda inflamatoria	<i>Campylobacter</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>C. difficile</i>	Las mismas + CMV , bacteriemia por <i>Salmonella</i>
Aguda acuosa	Virus, toxinas alimentarias, <i>E. coli</i>	<i>Cryptosporidium</i> , <i>Cystoisospora belli</i> , <i>Cyclospora</i>
Crónica	Fármacos (inhibidores de proteasa), síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca	Criptosporidiosis , microsporidiosis, MAC, CMV, <i>Cystoisospora</i> , enteropatía por VIH
Proctitis	<i>N. gonorrhoeae</i> , <i>C. trachomatis</i> (incluido LGV), sífilis, VHS	Igual

4.3 Estudio

- Coprocultivo, panel molecular gastrointestinal si está disponible, toxina/PCR de *C. difficile*.
- **Parasitológico seriado más tinciones especiales:** Ziehl-Neelsen modificado (Kinyoun) para *Cryptosporidium*, *Cystoisospora* y *Cyclospora*; tinción tricrómica modificada para microsporidios. **Estas tinciones hay que pedir las explícitamente: no vienen en el parasitológico estándar.**
- Hemocultivos si fiebre (bacteriemia por *Salmonella* recurrente define etapa SIDA).
- **Colonoscopia con biopsias** si diarrea crónica y estudio no invasivo negativo: es el examen que hace el diagnóstico de colitis por CMV (cuerpos de inclusión) y de MAC.

4.4 Notas de tratamiento

- **Criptosporidiosis:** el tratamiento eficaz es **la reconstitución inmune con TARV**. Nitazoxanida tiene beneficio marginal si CD4 muy bajos y no reemplaza a la TARV.
- **Cystoisospora belli / Cyclospora:** cotrimoxazol.
- **Colitis por CMV:** ganciclovir IV (o valganciclovir si tolera vía oral y enfermedad no grave), 21-42 días, según respuesta.
- **Microsporidiosis:** albendazol (*Encephalitozoon*); *Enterocytozoon bieneusi* responde mal — de nuevo, TARV.
- **Diarrea por fármacos:** frecuente con inhibidores de proteasa; se maneja sintomáticamente sin suspender la TARV salvo intolerancia mayor.

Callout. Toda diarrea crónica en VIH avanzado obliga a **pedir las tinciones especiales y, si son negativas, a endoscopiar**. Etiquetarla de "enteropatía por VIH" sin ese estudio es un error frecuente.

5. Odinofagia y esofagitis

Etiología	Clínica orientadora	Endoscopia	Tratamiento
Candida (más frecuente)	Disfagia y odinofagia, muguet oral en la mayoría	Placas blanquecinas adherentes	Fluconazol oral 14-21 días; empírico si hay muguet
CMV	Odinofagia intensa, CD4 < 50, fiebre	Úlcera única, grande, profunda	Ganciclovir/valganciclovir
VHS	Odinofagia, lesiones orales herpéticas	Úlceras múltiples, pequeñas, superficiales	Aciclovir
Úlcera aftosa idiopática	Diagnóstico de exclusión	Úlcera sin agente identificable en biopsia	Corticoides o talidomida (especialista)

Conducta estándar: en un paciente con CD4 bajos, muguet y odinofagia, se **trata empíricamente con fluconazol** y se reevalúa a los 5-7 días. **Si no mejora -> endoscopia digestiva alta con biopsias**, que es la que distingue CMV de VHS de candidiasis resistente.

6. Compromiso hepático y de la vía biliar

6.1 Causas de alteración del perfil hepático

- **Coinfecciones:** VHB y VHC (tamizaje obligatorio en toda persona con VIH; repetir según riesgo). La coinfección acelera la fibrosis.
- **Toxicidad farmacológica:** nevirapina (hepatitis, sobre todo CD4 altos), efavirenz, inhibidores de proteasa, cotrimoxazol, isoniacida, rifampicina, antifúngicos azólicos.
- **Infiltrativas/granulomatosas:** TB, MAC, histoplasmosis, linfoma — patrón **colestásico con fosfatasas alcalinas muy elevadas**.
- **Esteatosis metabólica** y consumo de alcohol: hoy causas muy prevalentes en pacientes bien controlados.
- **Colangiopatía asociada al VIH** (CD4 < 100): estenosis papilar y colangitis esclerosante secundaria a *Cryptosporidium*, CMV o microsporidios; dolor en hipocondrio derecho con **FA muy alta y bilirrubina normal o poco elevada**; se estudia con ecografía y **colangiografía (CPRE)**, que además puede ser terapéutica con esfinterotomía. El tratamiento de fondo es la TARV.

6.2 Puntos prácticos con VHB

- **Nunca tratar el VHB en una persona con VIH con un solo fármaco activo:** el esquema de TARV debe incluir **tenofovir + lamivudina/emtricitabina**.
- **No suspender tenofovir/lamivudina sin plan**, por riesgo de **reactivación grave del VHB**.
- Vacunar contra VHB a todo paciente susceptible (ver documento de vacunas).

7. Citopenias

Citopenia	Causas específicas a considerar
Anemia	VIH per se (normocítica), MAC , TB, parvovirus B19 (aplasia pura de serie roja, reticulocitos bajos), CMV, linfoma, zidovudina (macrocitosis), déficit nutricionales, hemólisis por dapsona/primaquina en déficit de G6PD
Neutropenia	VIH, zidovudina, ganciclovir, cotrimoxazol, infiltración medular
Trombocitopenia	PTI asociada al VIH (puede ser la manifestación de presentación), PTT, hiperesplenismo, fármacos, coinfección VHC

Notas:

- La **PTI asociada al VIH** mejora con la TARV; ese es el tratamiento de primera línea, reservando corticoides o inmunoglobulina para hemorragia o plaquetas muy bajas.
- **Parvovirus B19:** sospechar ante anemia arregenerativa; se confirma con PCR en sangre y se trata con **inmunoglobulina IV** más TARV.
- **Pancitopenia + fiebre + esplenomegalia** en CD4 < 100 obliga a considerar **mielograma y biopsia de médula ósea con cultivos para micobacterias y hongos**: es el examen que rinde en MAC, TB diseminada, histoplasmosis y linfoma.

8. Sarcoma de Kaposi

- **Agente:** virus herpes humano 8 (VHH-8). Es una **condición definitoria de SIDA (etapa C)**.
- **Clínica:** lesiones cutáneas violáceas, no dolorosas, que no blanquean, en piel y mucosas (paladar), con distribución siguiendo líneas de tensión; **linfedema** desproporcionado. Compromiso visceral: **gastrointestinal** (sangrado) y **pulmonar** (disnea, infiltrados peribroncovasculares, derrame; puede simular una infección).
- **Diagnóstico: biopsia.** No se diagnostica solo por el aspecto.
- **Etapificación:** evaluar mucosa oral, hacer test de hemorragias ocultas/endoscopia si hay síntomas y radiografía o TC de tórax.
- **Tratamiento:** la **TARV es la base y basta en enfermedad cutánea limitada**. Enfermedad extensa, visceral sintomática o rápidamente progresiva requiere **quimioterapia sistémica (antraciclinas liposomales, taxanos)** además de TARV — indicación del oncólogo.
- **Ojo con el SIRI:** el SK puede empeorar transitoriamente al iniciar TARV.

9. Linfomas asociados al VIH

Entidad	Contexto	Rasgos
LNH difuso de células grandes B	Cualquier CD4, más frecuente si bajos	Masas, fiebre B, LDH alta, compromiso extranodal
Linfoma de Burkitt	CD4 relativamente conservados	Muy alta tasa de proliferación, riesgo de síndrome de lisis tumoral
Linfoma primario del SNC	CD4 < 50 , VEB en LCR	Lesión única o pocas, con realce; ver documento de complicaciones del SNC
Linfoma primario de cavidades (efusiones)	VHH-8	Derrames sin masa
Linfoma de Hodgkin	Incidencia aumentada aunque no es definitorio de SIDA	—

- LNH de alto grado y linfoma primario del SNC son **condiciones definitorias de SIDA**.
- **Diagnóstico: biopsia** (evitar solo punción con aguja fina).
- El tratamiento es quimioterapia estándar **junto con TARV**: hoy los resultados se aproximan a los de la población sin VIH cuando la TARV está optimizada. Evaluar interacciones entre antirretrovirales y quimioterapia con farmacia clínica (los inhibidores de proteasa potenciados con ritonavir/cobicistat son los más problemáticos).
- Profilaxis del SNC y del síndrome de lisis tumoral según protocolo hematológico.

10. Otras neoplasias y el tamizaje que corresponde

- **Cáncer cervicouterino invasor**: condición definitoria de SIDA. **Citología cervical al diagnóstico de VIH y luego según norma**, con seguimiento más frecuente que en la población general.
- **Cáncer anal (VPH)**: incidencia muy aumentada, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Tacto rectal y, donde esté disponible, citología anal.
- **Cáncer pulmonar**: riesgo aumentado, en parte por tabaquismo; **la intervención de mayor rendimiento es la cesación del tabaco**.
- **Hepatocarcinoma** en coinfectados con VHB/VHC: tamizaje ecográfico según guía de hepatología.
- **Vacunación contra VPH** según el Programa Nacional de Inmunizaciones y las recomendaciones para personas con VIH — **verificar la norma vigente del MINSAL**.

11. Compromiso renal, cutáneo y oftalmológico

Renal

- **Nefropatía asociada al VIH (HIVAN)**: glomeruloesclerosis focal y segmentaria colapsante, proteinuria en rango nefrótico, riñones de tamaño conservado o aumentado; más frecuente en personas de ascendencia africana. **El tratamiento es la TARV**, más bloqueo del eje renina-angiotensina; el rol de los corticoides es discutido.
- **Toxicidad por tenofovir disoproxil**: tubulopatía proximal/síndrome de Fanconi, caída de filtración glomerular y pérdida de densidad mineral ósea. **Tenofovir alafenamida** tiene mejor perfil renal y óseo.
- Nefrolitiasis por atazanavir; elevaciones de creatinina **sin caída real de filtración** por dolutegravir, rilpivirina y cobicistat (inhiben la secreción tubular de creatinina) — **no confundir con daño renal**.

Cutáneo

- Dermatitis seborreica, foliculitis eosinofílica, prurigo, psoriasis exacerbada.
- **Angiomatosis bacilar** (*Bartonella henselae/quintana*): lesiones vasculares que **simulan sarcoma de Kaposi**; se distinguen por biopsia y responden a **doxiciclina o macrólidos** (ver documento de bartonelosis).
- Molusco contagioso extenso y verrugas de difícil manejo con CD4 bajos.
- **Reacciones a fármacos**: exantema por cotrimoxazol, abacavir (hipersensibilidad — *HLA-B5701**), nevirapina (riesgo de Stevens-Johnson).

Oftalmológico

- **Retinitis por CMV (CD4 < 50)**: pérdida visual indolora, moscas volantes; **fondo de ojo con hemorragias y exudados perivasculares ("queso y ketchup")**. Requiere evaluación oftalmológica urgente y tratamiento con valganciclovir/ganciclovir (con terapia intravítrea si la lesión amenaza la mácula o el nervio óptico).

- **Regla:** todo paciente con CD4 < 50 debe tener **fondo de ojo por oftalmólogo**, aunque esté asintomático.

12. Cuándo el problema es la TARV y no una infección

Manifestación	Fármacos sospechosos
Exantema y fiebre en los primeros días-semanas	Abacavir (hipersensibilidad, no reexponer nunca), nevirapina, efavirenz, cotrimoxazol
Náuseas, diarrea	Inhibidores de proteasa
Insomnio, sueños vívidos, síntomas neuropsiquiátricos	Efavirenz, dolutegravir (menor grado)
Aumento de peso, dislipidemia, resistencia insulínica	Inhibidores de integrasa (sobre todo con tenofovir alafenamida), inhibidores de proteasa
Acidosis láctica, lipoatrofia, neuropatía	Análogos de nucleósidos antiguos (estavudina, didanosina, zidovudina) — en desuso
Elevación aislada de creatinina	Dolutegravir, rilpivirina, cobicistat
Ictericia sin daño hepático	Atazanavir (hiperbilirrubinemia indirecta)

Callout. Ante cualquier síntoma nuevo en un paciente con TARV, revisar **siempre** la lista de fármacos e interacciones (antiácidos y cationes divalentes con inhibidores de integrasa, rifampicina, estatinas, corticoides inhalados con potenciadores). Consultar con farmacia clínica y con una base de interacciones validada.

13. Errores frecuentes

1. Estudiar una **fiebre sin foco** sin pedir **CD4 y carga viral actuales**: sin ellos el diferencial no se puede construir.
2. **No pedir tinciones especiales** en el parasitológico de una diarrea crónica y concluir "enteropatía por VIH".
3. Tratar una odinofagia con fluconazol, no reevaluar y **no endoscopiar** cuando no responde en 5-7 días.
4. **Suspender tenofovir/lamivudina** en un coinfectado con VHB sin plan, con reactivación grave.
5. Atribuir a colestasia obstructiva unas **fosfatasas alcalinas muy altas** que en realidad corresponden a MAC, TB o linfoma.
6. Diagnosticar **sarcoma de Kaposi o angiomatosis bacilar por el aspecto**, sin biopsia — el tratamiento es completamente distinto.
7. Olvidar el **fondo de ojo con CD4 < 50**: la retinitis por CMV puede ser silente hasta la pérdida visual.
8. Interpretar el **alza de creatinina por dolutegravir o cobicistat** como falla renal y cambiar el esquema innecesariamente.
9. **Reexponer a abacavir** a un paciente con antecedente de hipersensibilidad: puede ser fatal.
10. Iniciar quimioterapia sin revisar **interacciones con la TARV**.

14. Perlas de alto rendimiento

- **Fiebre + fosfatasas alcalinas altas + anemia + CD4 < 50 -> MAC diseminado** hasta demostrar lo contrario; pedir hemocultivos para micobacterias.
- **Úlcera esofágica única y grande -> CMV**; **úlceras múltiples y pequeñas -> VHS**.
- **Criptosporidiosis: el tratamiento es la TARV**.
- **Anemia arregenerativa con reticulocitos bajos -> parvovirus B19**, se trata con inmunoglobulina IV.
- **Trombocitopenia aislada puede ser la forma de presentación del VIH**; en toda trombocitopenia inexplicada, ofrecer test de VIH.
- **Colangiopatía del VIH**: dolor en hipocondrio derecho con FA muy alta y bilirrubina casi normal, CD4 < 100.
- **SK cutáneo limitado se trata solo con TARV**; el visceral sintomático requiere quimioterapia.
- **VHB coinfectado: el esquema debe llevar tenofovir + lamivudina/emtricitabina**, nunca monoterapia activa frente al VHB.
- **CD4 < 50 -> fondo de ojo por oftalmólogo, aunque no haya síntomas**.
- Ante cualquier deterioro en las primeras 4-12 semanas de TARV, considerar **SIRI** antes de asumir fracaso terapéutico.

15. Bibliografía esencial

1. **Panel on Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV (NIH, CDC, IDSA, HIVMA).** *Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV.* Actualización continua en clinicalinfo.hiv.gov.
2. **Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents (DHHS).** *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV.* Actualización continua.
3. **European AIDS Clinical Society (EACS).** *EACS Guidelines* (versión vigente): comorbilidades, coinfecciones e interacciones farmacológicas.
4. **Organización Mundial de la Salud.** *Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring.*
5. **MINSAL, Chile.** *Guía Clínica AUGE/GES: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA y normas del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS.* **Verificar la versión vigente.**
6. **Ley 19.779,** que establece normas relativas al VIH y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas (consentimiento informado, confidencialidad y no discriminación).
7. **UpToDate.** Temas: *Approach to the adult with HIV and fever, Evaluation of diarrhea in patients with HIV, AIDS-related Kaposi sarcoma, HIV-associated lymphomas, HIV-associated nephropathy.*
8. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: complicaciones del VIH avanzado.
9. **University of Liverpool.** *HIV Drug Interactions* (hiv-druginteractions.org): referencia estándar para interacciones de la TARV.

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS.